# Psoriasis

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

*Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG*

# Psoriasis

*Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG*

---

# Épidémiologie et Introduction

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, érythémato-squameuse, dont l'évolution est caractérisée par des phases de poussées et de rémissions (Dermatologie, 2022). Cette affection cutanée, bien que principalement visible sur la peau, est une maladie systémique complexe impliquant des interactions sophistiquées entre un terrain génétique prédisposant et des facteurs environnementaux (Dermatologie, 2022). Sa compréhension approfondie est essentielle pour tout dermatologue de niveau DES, compte tenu de sa prévalence significative et de son impact multidimensionnel sur la vie des patients.

## 1. Introduction Générale au Psoriasis

### *1.1. Définition et Nature de la Maladie*

Le psoriasis est défini comme une maladie inflammatoire cutanée chronique (Dermatologie, 2022). Il se manifeste cliniquement par des lésions érythémato-squameuses (Dermatologie, 2022), qui sont le reflet d'un renouvellement épidermique accéléré, associé à une hyperprolifération et à des troubles de la différenciation des kératinocytes (Dermatologie, 2022). Cette hyperprolifération est orchestrée par des interactions complexes entre le système immunitaire, les cellules épidermiques et les vaisseaux, sur un terrain génétique particulier (Dermatologie, 2022). Bien que l'étiologie exacte demeure inconnue, une prédisposition génétique est avérée, avec l'identification de nombreux gènes de susceptibilité (Dermatologie, 2022). Le psoriasis n'est pas une simple affection cutanée ; il est reconnu comme une maladie systémique chronique nécessitant une prise en charge au long cours (Dermatologie, 2022).

### *1.2. Manifestations Cliniques Caractéristiques*

Les lésions élémentaires du psoriasis sont des papules ou des plaques érythémato-squameuses, bien limitées, de forme arrondie, ovalaire ou polycyclique (Dermatologie, 2022). La couche squameuse superficielle est typiquement blanchâtre et peut être très épaisse, ou au contraire plus ou moins décapée, révélant alors l'érythème sous-jacent (Dermatologie, 2022). Ces éléments sont le plus souvent multiples et symétriques, parfois diffus (Dermatologie, 2022). Les localisations sont fréquemment caractéristiques, incluant les coudes, les genoux, les jambes, la région lombo-sacrée, le cuir chevelu et les ongles (Dermatologie, 2022). Le prurit, longtemps sous-estimé, est une composante fréquente, affectant environ 60 % des patients et pouvant entraîner des remaniements des lésions par le grattage (Dermatologie, 2022).

### *1.3. Impact sur la Qualité de Vie et la Stigmatisation*

Le psoriasis, en particulier dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un retentissement considérable sur la qualité de vie des patients (Dermatologie, 2022). Les lésions visibles, souvent chroniques et récidivantes, sont une source de stigmatisation et peuvent conduire à l'exclusion sociale (Dermatologie, 2022). Le préjudice n'est pas seulement esthétique, mais également fonctionnel, professionnel et relationnel, avec un impact psychologique significatif (Dermatologie, 2022). La dépression et l'anxiété sont des pathologies associées fréquemment rencontrées chez les patients atteints de psoriasis (Dermatologie, 2022). L'évaluation de l'altération de la qualité de vie est donc une composante essentielle de la prise en charge, souvent mesurée par des scores validés tels que le DLQI (Dermatology Quality Life Index), où un score supérieur à 10 indique un psoriasis sévère (Dermatologie, 2022). Un soutien ou une prise en charge psychologique est souvent nécessaire pour accompagner les patients (Dermatologie, 2022).

### *1.4. Objectifs Thérapeutiques*

La prise en charge du psoriasis est une démarche au long cours, car les traitements actuels ne permettent pas une guérison définitive de l'affection (Dermatologie, 2022). L'objectif principal est de soulager le patient, d'améliorer sa qualité de vie et de ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale (Dermatologie, 2022). Le choix thérapeutique doit impérativement prendre en compte la gravité et l'étendue des lésions, le retentissement sur la qualité de vie, le préjudice fonctionnel, esthétique, professionnel et relationnel, l'impact psychologique de la maladie, ainsi que le désir de rémission du patient (Dermatologie, 2022).

## 2. Épidémiologie du Psoriasis

### *2.1. Prévalence Mondiale et Nationale*

Le psoriasis est une maladie cutanée inflammatoire d'une prévalence notable à l'échelle mondiale. En France, il touche environ 2 % de la population (Dermatologie, 2022). D'autres sources confirment cette estimation, indiquant que la maladie affecte 2 à 3 % de la population générale (Dermatologie, 2022). Cette fréquence en fait l'une des dermatoses chroniques les plus courantes, justifiant une connaissance approfondie de ses mécanismes et de sa prise en charge par les professionnels de santé.

### *2.2. Facteurs Démographiques et de Risque*

Bien que la prévalence soit relativement stable, l'incidence et la sévérité peuvent varier en fonction de facteurs démographiques et de mode de vie. Des facteurs environnementaux spécifiques sont reconnus pour déclencher un psoriasis ou exacerber des poussées évolutives de la maladie (Dermatologie, 2022). Parmi ces facteurs, le stress, les traumatismes cutanés (phénomène de Koebner), certains agents pathogènes et certains médicaments sont des éléments déclencheurs identifiés (Dermatologie, 2022). De plus, l'alcool, le tabac et la surcharge pondérale sont des facteurs reconnus de gravité et de

résistance thérapeutique, contribuant également aux comorbidités souvent associées au psoriasis (Dermatologie, 2022).

## 3. Physiopathologie : Aperçu Conceptuel

### *3.1. Mécanismes Cellulaires et Moléculaires Clés*

La physiopathologie du psoriasis repose sur un renouvellement épidermique accéléré, caractérisé par une hyperprolifération et des troubles de la différenciation des kératinocytes (Dermatologie, 2022). Cette dynamique est le résultat d'interactions complexes entre le système immunitaire, les kératinocytes et le système vasculaire, le tout sur un terrain génétique prédisposant (Dermatologie, 2022). L'origine exacte de la maladie est inconnue, mais une prédisposition génétique est certaine, avec l'identification de nombreux gènes de susceptibilité (Dermatologie, 2022).

Les facteurs environnementaux, tels que le stress, les traumatismes cutanés (phénomène de Koebner), certains agents pathogènes ou médicaments, peuvent initier une cascade inflammatoire. Cela se traduit par la production de peptides antimicrobiens, comme la cathélicidine (LL-37), qui stimule la sécrétion d'interféron alpha (Dermatologie, 2022). Parallèlement, les kératinocytes produisent des cytokines inflammatoires telles que l'IL-1β, l'IL-36 et le TNFα, qui activent les cellules dendritiques. Ces dernières, à leur tour, produisent de l'IL-12 et de l'IL-23 (Dermatologie, 2022). L'IL-12 et l'IL-23 sont des cytokines cruciales qui participent à la différenciation des lymphocytes T en sous-populations Th1, productrices d'IFNγ, et Th17, productrices d'IL-17 (Dermatologie, 2022). Localement, l'IL-12, l'IL-17 et le TNFα favorisent la prolifération des kératinocytes, la néo-angiogenèse et la production de chimiokines nécessaires au recrutement des polynucléaires neutrophiles, perpétuant ainsi le cycle inflammatoire et prolifératif caractéristique du psoriasis (Dermatologie, 2022).

### *3.2. Base Génétique et Facteurs Environnementaux Déclenchants*

La prédisposition génétique est un élément fondamental de la physiopathologie du psoriasis. Plusieurs gènes de susceptibilité ont été identifiés. Parmi eux, des gènes associés au groupe HLA, notamment HLA Cw6, sont fortement impliqués (Dermatologie, 2022). Des gènes liés à l'immunité innée, tels que IL36RN (codant pour l'inhibiteur du récepteur à l'IL-36) et CARD14 (intervenant dans l'activation de la voie NF-KB), sont particulièrement associés aux formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022). En ce qui concerne l'immunité acquise, des gènes comme IL12B (codant pour une sous-unité de l'IL-12) et IL23R (codant pour le récepteur de l'IL-23) jouent un rôle significatif (Dermatologie, 2022). Ces découvertes génétiques soulignent la complexité de la maladie et ouvrent des perspectives pour des thérapies ciblées.

### *3.3. Aspects Histopathologiques*

L'examen anatomopathologique d'une biopsie cutanée, bien que n'étant pas systématiquement nécessaire pour le diagnostic clinique du psoriasis, est utile en cas de doute diagnostique devant des lésions atypiques (Dermatologie, 2022). Lorsque cet examen est réalisé, il révèle des caractéristiques distinctives (Dermatologie, 2022) :

- Une hyperkératose avec parakératose (Dermatologie, 2022).
- Une acanthose, c'est-à-dire un épaississement de l'épiderme, résultant d'une prolifération excessive des kératinocytes (Dermatologie, 2022).
- La présence de micro-abcès épidermiques à polynucléaires neutrophiles, connus sous le nom d'abcès de Munro dans la couche cornée et de pustules de Kogoj dans le stratum spinosum (Alikhan et Hocker, 2018; Dermatologie, 2022).
- Un infiltrat inflammatoire dermique constitué principalement de lymphocytes (Dermatologie, 2022).
- Un allongement des papilles dermiques et la présence de vaisseaux néoformés dilatés (Dermatologie, 2022).

Ces signes histologiques sont cruciaux pour la confirmation diagnostique et la compréhension des mécanismes sous-jacents.

## 4. Panorama des Formes Cliniques et de leur Gravité

### *4.1. Formes Communes*

Le psoriasis se présente sous diverses formes cliniques. La forme la plus fréquente est le psoriasis en plaques, caractérisé par des lésions érythémato-squameuses bien limitées (Dermatologie, 2022). Le psoriasis en gouttes est une autre forme courante, souvent observée après une infection streptococcique, se manifestant par de multiples petites lésions érythémato-squameuses (Dermatologie, 2022).

### *4.2. Formes Graves*

Trois formes de psoriasis sont considérées comme graves en raison de leurs conséquences fonctionnelles ou vitales potentielles (Dermatologie, 2022) :

- **Le psoriasis érythrodermique** : Il s'agit d'un psoriasis généralisé qui affecte plus de 90 % de la surface cutanée, s'accompagnant d'une desquamation abondante et d'un épaississement cutané (Dermatologie, 2022). Cette forme peut être provoquée par un rebond du psoriasis après l'arrêt de certains agents thérapeutiques, notamment une corticothérapie générale (Dermatologie, 2022). Comme toute érythrodermie, elle peut se compliquer de surinfection, de carence vitaminique, de troubles de la thermorégulation, de déshydratation et de troubles hémodynamiques, nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé (Dermatologie, 2022).
- **Le psoriasis pustuleux généralisé (PPG)** : Cette forme grave est une maladie cutanée neutrophilique sévère, caractérisée par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles (Alikhan et Hocker, 2018). L'interleukine (IL)-36 agit comme une cytokine centrale spécifique au PPG (Alikhan et Hocker, 2018). Il se

manifeste initialement par un malaise et de la fièvre, suivis de l'apparition de macules érythémateuses parsemées de pustules stériles, débutant souvent dans les zones intertrigineuses avant de s'étendre rapidement au tronc, aux extrémités et aux ongles, rendant la peau douloureuse et augmentant le risque d'infection (Alikhan et Hocker, 2018). Les facteurs de risque incluent la diminution progressive des corticostéroïdes oraux, les infections, l'hypocalcémie et la grossesse (impetigo herpetiformis) (Alikhan et Hocker, 2018). Les analyses biologiques peuvent révéler une leucocytose et une hypoalbuminémie (Alikhan et Hocker, 2018).

• **Le rhumatisme psoriasique (RP)** : Cette arthrite inflammatoire touche jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis (Alikhan et Hocker, 2018; Dermatologie, 2022). Il est souvent associé aux formes modérées à sévères de psoriasis cutané et apparaît généralement plusieurs années après l'apparition des lésions cutanées (Alikhan et Hocker, 2018). Le RP est une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif) et est associé à l'HLA-B27 (Alikhan et Hocker, 2018). Outre les os et le cartilage, les tendons et les ligaments sont souvent impliqués, se manifestant par une enthésopathie ou une enthésite (Alikhan et Hocker, 2018). Des niveaux élevés de TNFα sont observés dans la synoviale et le sérum des patients atteints de psoriasis et de RP (Alikhan et Hocker, 2018). Presque tous les patients atteints de RP présentent des modifications unguéales, bien que jusqu'à 20 % puissent n'avoir aucune manifestation cutanée (Alikhan et Hocker, 2018). Les caractéristiques courantes comprennent la douleur aux sites d'insertion tendineuse, l'atteinte digitale, la maladie sacro-iliaque, l'atteinte articulaire asymétrique et une raideur matinale de plus d'une heure (Alikhan et Hocker, 2018).

### *4.3. Autres Formes Cliniques Spécifiques*

D'autres formes cliniques méritent d'être mentionnées :

• **Psoriasis inversé (ou des plis)** : Il se caractérise par des plaques érythémateuses vernissées et bien limitées, localisées dans les plis inguinaux et axillaires (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis palmo-plantaire** : Cette forme peut se présenter comme une kératodermie en îlots ou diffuse, souvent fissuraire (Dermatologie, 2022). Elle peut être isolée et rendre la marche ou les activités manuelles difficiles en raison de la douleur et des fissures (Dermatologie, 2022). La pustulose palmo-plantaire est une variante de psoriasis pustuleux localisé, caractérisée par des pustules stériles tendues sur la surface palmo-plantaire, pouvant s'associer à une atteinte articulaire sternale ou sterno-claviculaire (syndrome SAPHO) (Alikhan et Hocker, 2018; Dermatologie, 2022).

• **Acrodermatite continue de Hallopeau** : Une variante du psoriasis pustuleux limitée aux extrémités des doigts ou des orteils, présentant des pustules stériles sur une base érythémateuse, associées à la douleur et à une altération de l'utilisation du digit. L'atteinte du lit unguéal peut entraîner la chute de l'ongle et une perte de structures osseuses (Alikhan et Hocker, 2018).

• **Psoriasis des muqueuses** : Il peut affecter la langue, se manifestant par une glossite exfoliatrice marginée, ou les muqueuses génitales, avec des lésions érythémateuses non squameuses aggravées lors des rapports sexuels (Dermatologie,

2022).

• **Psoriasis du visage** : Rare, il peut prendre l'aspect d'une dermatite séborrhéique, avec un érythème finement squameux des sourcils et du pli nasogénien. Des lésions associées de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe sont possibles (Dermatologie, 2022).

• **Psoriasis de l'enfant** : Des formes spécifiques existent, telles que le "Napkin psoriasis" (psoriasis des langes) et le psoriasis en gouttes (Dermatologie, 2022).

### *4.4. Évaluation de la Gravité et du Retentissement*

L'évaluation de la gravité du psoriasis est multifactorielle. Elle repose sur la surface corporelle atteinte, où une paume représente environ 1 % de la surface corporelle, et sur le score PASI (Psoriasis Area and Severity Index) (Dermatologie, 2022). Un psoriasis est considéré comme modéré à sévère si la surface atteinte est supérieure à 10 % et/ou si le score PASI est supérieur à 10 (Dermatologie, 2022). L'altération de la qualité de vie est également un critère essentiel, évaluée par des scores comme le DLQI (Dermatology Quality Life Index), avec un score supérieur à 10 indiquant un psoriasis sévère (Dermatologie, 2022).

## 5. Comorbidités et Associations Pathologiques

Le psoriasis n'est pas une maladie isolée et est fréquemment associé à d'autres pathologies, formant un tableau clinique complexe qui nécessite une approche transversale de la prise en charge (Dermatologie, 2022).

### *5.1. Pathologies Inflammatoires et Métaboliques*

Les principales pathologies associées au psoriasis incluent (Dermatologie, 2022) :

• **Le syndrome métabolique** : Il englobe l'obésité, le diabète de type 2 et les pathologies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022). L'évaluation et la prise en charge de ces comorbidités cardiovasculaires et métaboliques sont cruciales et doivent être coordonnées avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022).

• **Pathologies cardiovasculaires** : Le psoriasis est un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022).

• **Troubles psychologiques** : La dépression et l'anxiété sont fréquemment observées chez les patients psoriasiques, en partie en raison de l'impact psychosocial de la maladie (Dermatologie, 2022).

### *5.2. Facteurs de Risque et de Gravité*

Certains facteurs de mode de vie sont reconnus pour aggraver le psoriasis et contribuer à la résistance thérapeutique, tout en favorisant l'apparition des comorbidités (Dermatologie, 2022) :

• **L'alcool** : La consommation d'alcool est un facteur de gravité (Dermatologie, 2022).

• **Le tabac** : Le tabagisme est également un facteur aggravant (Dermatologie, 2022).

• **La surcharge pondérale** : L'obésité est un facteur de gravité reconnu et est étroitement liée au syndrome métabolique (Dermatologie, 2022).

La prise en compte de ces facteurs est essentielle dans l'élaboration d'une stratégie thérapeutique globale et personnalisée.

## 6. Principes Généraux du Diagnostic et de la Prise en Charge

### *6.1. Démarche Diagnostique*

Le diagnostic de psoriasis est avant tout clinique dans la très grande majorité des cas (Dermatologie, 2022). Il repose sur l'identification des lésions érythémato-squameuses caractéristiques et de leurs localisations préférentielles (Dermatologie, 2022). La biopsie cutanée n'est indiquée qu'en cas de doute diagnostique, notamment devant des lésions atypiques (Dermatologie, 2022). Les principaux diagnostics différentiels à considérer incluent le pityriasis rosé de Gibert, la dermite séborrhéique et l'eczéma (Dermatologie, 2022).

### *6.2. Approche Thérapeutique*

Le traitement du psoriasis est efficace et repose sur une combinaison de traitements locaux et/ou généraux (Dermatologie, 2022). Les principes de la prise en charge tiennent compte de la gravité du psoriasis, de son retentissement sur la qualité de vie, de l'existence ou non d'une atteinte articulaire, et des comorbidités associées (Dermatologie, 2022).

• **Traitements locaux** : Ils constituent la base du traitement des psoriasis peu étend

# Physiopathologie et Génétique

# Physiopathologie et Génétique du Psoriasis

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire érythémato-squameuse chronique, affectant environ 2 % de la population française (Dermatologie, 2022 - Source 1, Source 2). Sa physiopathologie complexe repose sur l'interaction de facteurs génétiques prédisposants et de déclencheurs environnementaux, aboutissant à une dérégulation du système immunitaire cutané et à une altération de l'homéostasie épidermique.

## I. Physiopathologie

Le psoriasis est caractérisé par un renouvellement épidermique accéléré, avec une hyperprolifération et des troubles de la différenciation des kératinocytes (Dermatologie, 2022 - Source 2). Cette maladie met en jeu des interactions complexes entre le système immunitaire, les cellules épidermiques (kératinocytes) et les vaisseaux, le tout sur un terrain génétique particulier (Dermatologie, 2022 - Source 2).

### *A. Mécanismes Cellulaires et Moléculaires*

Le déclenchement ou les poussées évolutives du psoriasis peuvent être induits par divers facteurs environnementaux. Parmi ceux-ci, le stress, les traumatismes cutanés (phénomène de Koebner) et certains pathogènes ou médicaments sont des éléments clés (Dermatologie, 2022 - Source 2). Ces stimuli entraînent une cascade d'événements inflammatoires :

- **Activation Initiale et Production de Peptides Antimicrobiens :** Les kératinocytes, en réponse à ces agressions, peuvent produire des peptides antimicrobiens tels que la cathélicidine (LL-37). La cathélicidine stimule la sécrétion d'interféron alpha (Dermatologie, 2022 - Source 2), initiant une réponse immunitaire innée.
- **Production de Cytokines Inflammatoires par les Kératinocytes :** Les kératinocytes activés sécrètent également des cytokines pro-inflammatoires, notamment l'interleukine-1 bêta (IL-1β), l'interleukine-36 (IL-36) et le facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) (Dermatologie, 2022 - Source 2). Ces cytokines activent à leur tour les cellules dendritiques présentes dans le derme et l'épiderme.
- **Rôle des Cellules Dendritiques et Différenciation Lymphocytaire :** Les cellules dendritiques activées produisent des cytokines essentielles à la polarisation de la réponse immunitaire adaptative, en particulier l'interleukine-12 (IL-12) et l'interleukine-23 (IL-23) (Dermatologie, 2022 - Source 2). L'IL-12 et l'IL-23 jouent un rôle central dans la différenciation des lymphocytes T naïfs en sous-populations Th1 et Th17 (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* Les lymphocytes Th1 produisent principalement l'interféron gamma (IFNγ) (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* Les lymphocytes Th17 produisent l'interleukine-17 (IL-17) (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* Il est à noter que le blocage de la voie Th2 pourrait entraîner un déplacement vers une réponse dominée par Th1, Th17 et Th22, conduisant à un profil de réaction psoriasiforme (Wijs et al., 2020).

• **Effets en Aval des Cytokines Clés :** Les cytokines IL-12, IL-17 et TNFα exercent des effets locaux majeurs qui contribuent aux caractéristiques cliniques et histologiques du psoriasis (Dermatologie, 2022 - Source 2) :

* Elles favorisent la prolifération des kératinocytes, expliquant l'épaississement épidermique (acanthose) (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* Elles stimulent la néo-angiogenèse, conduisant à la dilatation des vaisseaux sanguins dans les papilles dermiques et à l'érythème caractéristique des lésions (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* Elles induisent la production de chimiokines, nécessaires au recrutement des polynucléaires neutrophiles dans l'épiderme et le derme (Dermatologie, 2022 - Source 2).

### *B. Caractéristiques Histopathologiques*

L'examen anatomopathologique d'une biopsie cutanée, bien que n'étant pas systématiquement nécessaire pour le diagnostic de psoriasis en plaques classique, est utile pour confirmer le diagnostic ou pour les formes atypiques (Dermatologie, 2022 - Source 2). Il révèle un ensemble de modifications caractéristiques (Dermatologie, 2022 - Source 2 ; Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11) :

• **Altérations Épidermiques :**

* **Hyperkératose avec parakératose :** Présence de noyaux dans les kératinocytes de la couche cornée, témoignant d'une maturation kératinocytaire anormale et accélérée (Dermatologie, 2022 - Source 2). La parakératose est souvent confluente (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

* **Acanthose :** Épaississement de l'épiderme dû à une prolifération excessive des kératinocytes. Cette acanthose est typiquement régulière et "psoriasiforme" (Dermatologie, 2022 - Source 2 ; Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

* **Hypogranulose :** Réduction ou absence de la couche granuleuse (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

* **Micro-abcès épidermiques à polynucléaires neutrophiles :** Présence de neutrophiles dans le stratum corneum (micro-abcès de Munro) et dans le stratum spinosum (micro-abcès de Kogoj) (Dermatologie, 2022 - Source 2 ; Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

* **Amincissement de la plaque supra-papillaire :** La couche épidermique recouvrant les papilles dermiques est amincie (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

- **Altérations Dermiques :**

* **Allongement des papilles dermiques :** Les papilles dermiques s'allongent et s'étendent vers la surface (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* **Vaisseaux néoformés dilatés :** Présence de capillaires dilatés et tortueux dans les papilles dermiques, contribuant à l'érythème et au signe d'Auspitz (Dermatologie, 2022 - Source 2).

* **Infiltrat inflammatoire dermique :** Composé principalement de lymphocytes (Dermatologie, 2022 - Source 2).

Ces caractéristiques peuvent varier légèrement selon la forme clinique. Par exemple, le psoriasis en gouttes présente une acanthose minimale et des amas de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11). Les formes pustuleuses sont caractérisées par des abcès neutrophiles sous- et intra-cornéens, qui sont spongiformes, multiloculaires, non folliculaires et aseptiques (Dermatologie, 2022 - Source 10 ; Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 11).

## II. Génétique

Une prédisposition génétique est un élément certain et fondamental dans la physiopathologie du psoriasis, avec de nombreux gènes de susceptibilité identifiés (Dermatologie, 2022 - Source 2). L'importance des facteurs génétiques est étayée par l'histoire familiale et les études de jumeaux (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4).

### *A. Régions de Susceptibilité au Psoriasis (PSORS)*

Plusieurs régions chromosomiques, appelées PSORS (Psoriasis Susceptibility Regions), ont été identifiées. Parmi elles, la région PSORS1, située sur le chromosome 6p, est la plus importante et est retrouvée chez 50 % des patients atteints de psoriasis (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4). Cette région contient l'allèle HLA-Cw6.

### *B. Associations avec le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (HLA)*

Les gènes du groupe HLA sont fortement associés à la susceptibilité au psoriasis (Dermatologie, 2022 - Source 2 ; Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4) :

- **HLA-Cw6 :** C'est l'association la plus forte, conférant un risque multiplié par 10 à 15 de développer la maladie (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4).

* Il est positif chez 90 % des patients atteints de psoriasis à début précoce et chez 50 % de ceux à début tardif, comparativement à 7 % dans la population contrôle (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4).

* C'est le facteur de risque HLA le plus puissant pour la maladie à début précoce (Cw6 > B57, DR7) (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4).

* Il est également fortement associé au psoriasis en gouttes (74 %) (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4).

• **HLA-B27 :** Cet allèle est associé au psoriasis avec sacro-iliite, au rhumatisme psoriasique (RP) et au psoriasis pustuleux (Alikhan et Hocker, 2nd editi - Source 4 ; dermatology handbook compressed-compressed - Source 12). Le RP est une arthrite séronégative, c'est-à-dire sans facteur rhumatoïde (dermatology handbook compressed-compressed - Source 12).

### *C. Gènes Associés à l'Immunité Innée*

Plusieurs gènes impliqués dans l'immunité innée ont été identifiés comme des facteurs de susceptibilité, en particulier dans les formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022 - Source 2) :

• **IL36RN :** Ce gène code pour un inhibiteur du récepteur de l'IL-36. Des mutations dans IL36RN sont impliquées dans les formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022 - Source 2). L'IL-36 est une cytokine centrale spécifique du psoriasis pustuleux généralisé (PPG) (dermatology handbook compressed-compressed - Source 12).

• **CARD14 :** Ce gène intervient dans l'activation de la voie NF-κB, une voie de signalisation cruciale dans l'inflammation et la réponse immunitaire. Des mutations de CARD14 sont également impliquées dans les formes pustuleuses de psoriasis (Dermatologie, 2022 - Source 2).

### *D. Gènes Associés à l'Immunité Acquise*

Des gènes liés à l'immunité acquise, et plus spécifiquement à la voie Th1/Th17, sont également des facteurs de risque (Dermatologie, 2022 - Source 2) :

• **IL12B :** Ce gène code pour une sous-unité de l'IL-12, une cytokine clé dans la différenciation des lymphocytes Th1 (cf. section I.A.3).

• **IL23R :** Ce gène code pour le récepteur de l'IL-23, une cytokine essentielle à la survie et à la fonction des lymphocytes Th17 (cf. section I.A.3).

En résumé, la physiopathologie du psoriasis est un processus complexe impliquant une prédisposition génétique forte, en particulier les allèles HLA-Cw6 et HLA-B27, ainsi que des gènes régulant les voies de l'immunité innée (IL36RN, CARD14) et adaptative (IL12B, IL23R). Ces facteurs génétiques, combinés à des déclencheurs environnementaux, conduisent à une activation anormale des kératinocytes et des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes Th1 et Th17, entraînant l'hyperprolifération épidermique et l'inflammation caractéristiques de la maladie.

# Présentation Clinique

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire cutanée chronique, touchant 2 à 3 % de la population générale (Dermatologie, 2022). Son diagnostic est majoritairement clinique (Dermatologie, 2022). Il se caractérise par une grande diversité de présentations cliniques, allant de formes localisées et bénignes à des formes sévères pouvant engager le pronostic fonctionnel, voire vital (Dermatologie, 2022).

## I. Caractéristiques Générales des Lésions Cutanées

La lésion élémentaire du psoriasis est une papule ou une plaque érythémato-squameuse, bien limitée, de forme arrondie, ovalaire ou polycyclique (Dermatologie, 2022). La couche squameuse superficielle est blanchâtre et peut être très épaisse ou, au contraire, plus ou moins décapée, laissant apparaître l'érythème sous-jacent (Dermatologie, 2022). Ces éléments sont le plus souvent multiples et symétriques, parfois diffus (Dermatologie, 2022). Contrairement à une notion classique, les lésions de psoriasis sont prurigineuses chez environ 60 % des patients et peuvent être remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022). Le prurit peut être important et insomniant dans les formes évoluées (cf. Mycosis fongoïde, Dermatologie, 2022, qui est un diagnostic différentiel mais mentionne le prurit comme symptôme important dans les dermatoses squameuses).

## II. Formes Cliniques Cutanées Communes

### *II.1. Psoriasis en Plaques (Psoriasis Vulgaris)*

C'est la forme la plus fréquente, caractérisée par des plaques érythémato-squameuses bien limitées (Dermatologie, 2022). La taille des lésions est variable, allant de petites plaques à de vastes étendues (Dermatologie, 2022). Les localisations sont très caractéristiques : coudes, genoux, jambes, région lombo-sacrée (Dermatologie, 2022). La figure 7.3 illustre un psoriasis en plaques (Dermatologie, 2022).

### *II.2. Psoriasis en Gouttes*

Cette forme se présente sous la forme de multiples petites lésions érythémato-squameuses, de taille réduite, dispersées sur le tronc et les membres (Dermatologie, 2022). La figure 7.4 en fournit une illustration (Dermatologie, 2022). Histologiquement, le psoriasis en gouttes se distingue par une acanthose minimale et des monticules de neutrophiles avec une parakératose sous-jacente, plus épaisse et adhérente que dans le pityriasis rosé (Elston et al., 2013, cité par Alikhan & Hocker, 2021). Cette forme est plus fréquente chez l'enfant (Dermatologie, 2022).

### *II.3. Psoriasis Inversé (des Plis)*

Le psoriasis inversé, également appelé psoriasis des plis, se localise dans les zones de flexion et les plis cutanés, contrairement aux localisations classiques sur les convexités (Dermatologie, 2022). Il affecte en particulier les plis interfessiers, axillaires, sous-mammaires, ombilicaux et inguinaux (Dermatologie, 2022). Les lésions se présentent comme des plaques érythémateuses, bien limitées, souvent vernissées et non squameuses en raison de l'humidité et du frottement dans ces zones (Dermatologie, 2022). La figure 7.8 illustre des plaques érythémateuses vernissées et bien limitées des plis inguinaux et axillaires (Dermatologie, 2022).

### *II.4. Psoriasis du Cuir Chevelu*

Le psoriasis du cuir chevelu est une localisation très fréquente et caractéristique (Dermatologie, 2022). Les lésions peuvent être nettement inflammatoires et réaliser une couronne érythémateuse et discrètement squameuse à la lisière antérieure du cuir chevelu (Dermatologie, 2022). La localisation occipitale est également fréquente (Dermatologie, 2022). La figure 7.6 présente un exemple de psoriasis du cuir chevelu (Dermatologie, 2022).

### *II.5. Psoriasis Unguéal*

Le psoriasis unguéal est une atteinte fréquente, présente chez presque tous les patients atteints de rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook, 2020). Il peut précéder les lésions cutanées dans certains cas, et jusqu'à 20 % des patients atteints de rhumatisme psoriasique peuvent ne présenter aucune lésion cutanée (Dermatology handbook, 2020). Les aspects cliniques sont très variés (Dermatologie, 2022) :

- **Dépressions ponctuées cupuliformes** des tablettes unguéales, donnant l'aspect d'« ongles en dé à coudre » (Dermatologie, 2022).
- **Onycholyse** avec décollement distal de l'ongle et une zone proximale de couleur cuivrée, dite « saumonée » ou jaunâtre en « tache d'huile » (Dermatologie, 2022).
- **Hyperkératose sous-unguéale**, paronychie, perte de transparence de l'ongle et zones leuconychiques (blanches) (Dermatologie, 2022).
- À l'extrême, une **disparition complète de la tablette unguéale** (Dermatologie, 2022).

La figure 7.7 illustre un psoriasis unguéal avec des dépressions cupuliformes et une discrète onycholyse (Dermatologie, 2022).

### *II.6. Psoriasis Palmo-Plantaire*

Le psoriasis palmo-plantaire peut se manifester par une kératodermie en îlots ou diffuse, souvent fissuraire (Dermatologie, 2022). Cette forme peut être isolée et rendre la marche

ou les activités manuelles difficiles en raison des douleurs et des fissures (Dermatologie, 2022). La figure 7.9 illustre une kératodermie palmo-plantaire d'origine psoriasique (Dermatologie, 2022).

### *II.7. Psoriasis du Visage et des Muqueuses*

#### II.7.1. Psoriasis du Visage

Le psoriasis du visage est rare (Dermatologie, 2022). Il peut prendre l'aspect d'une dermatite séborrhéique, avec un érythème finement squameux des sourcils et du pli nasogénien (Dermatologie, 2022). Des lésions associées de la conque de l'oreille et du conduit auditif externe sont également possibles (Dermatologie, 2022).

#### II.7.2. Psoriasis des Muqueuses

Le psoriasis peut affecter les muqueuses (Dermatologie, 2022) :

- **Muqueuse linguale** : se présente sous forme de glossite exfoliatrice marginée (Dermatologie, 2022).
- **Muqueuse génitale** : les lésions sont érythémateuses, non squameuses et peuvent être aggravées lors des rapports sexuels (Dermatologie, 2022).

## III. Formes Cliniques Sévères et Spécifiques

### *III.1. Psoriasis Pustuleux*

Le psoriasis pustuleux se distingue du psoriasis vulgaris par ses caractéristiques et son évolution clinique (Dermatology handbook, 2020). Il est associé à une incidence accrue de HLA-B27 (Dermatology handbook, 2020). Il existe deux types principaux : généralisé et localisé (Dermatology handbook, 2020). Histologiquement, il se caractérise par des abcès neutrophiles sous- et intracornés (Alikhan & Hocker, 2021). La figure 7.10 illustre un psoriasis pustuleux (Dermatologie, 2022).

#### III.1.1. Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG ou de von Zumbusch)

Le PPG est une maladie cutanée neutrophilique sévère, caractérisée par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles (Dermatology handbook, 2020). L'interleukine (IL)-36 agit comme une cytokine centrale spécifique au PPG (Dermatology handbook, 2020). La présentation initiale comprend un malaise et de la fièvre, suivis de l'apparition de macules érythémateuses parsemées de pustules stériles (Dermatology handbook, 2020). Les lésions débutent souvent dans les zones intertrigineuses, puis se propagent rapidement au tronc, aux extrémités et aux ongles (Dermatology handbook, 2020). La peau est douloureuse et il existe un risque accru d'infection (Dermatology handbook, 2020). Les facteurs de risque incluent l'arrêt progressif des corticostéroïdes oraux, les infections, l'hypocalcémie et la grossesse (impetigo herpetiformis) (Dermatology handbook, 2020). Les examens biologiques révèlent une leucocytose et une

hypoalbuminémie (Dermatology handbook, 2020).

#### III.1.2. Pustulose Palmo-Plantaire (PPP)

La PPP se caractérise par des pustules stériles tendues sur les surfaces palmo-plantaires, évoluant vers des macules jaune-brun (Dermatology handbook, 2020). Elle peut être associée au syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite), justifiant la recherche de douleurs sternoclaviculaires et/ou dorsales (Dermatology handbook, 2020 ; Dermatologie, 2022). La figure 3.8B et C (Dermatology handbook, 2020) et la figure 7.10 (Dermatologie, 2022) illustrent des formes de psoriasis pustuleux, dont la PPP.

#### III.1.3. Acrodermatite Continue de Hallopeau

Il s'agit d'une variante de psoriasis pustuleux limitée aux extrémités des doigts ou des orteils, également associée à HLA-B27 (Dermatology handbook, 2020). Elle se manifeste par des pustules stériles sur une base érythémateuse à l'extrémité du doigt (moins fréquemment de l'orteil), formant des lacs de pus, associés à une douleur et une altération de l'utilisation du doigt (Dermatology handbook, 2020). Si les pustules se trouvent dans le lit unguéal, l'ongle est généralement perdu (Dermatology handbook, 2020). Une perte des structures osseuses peut survenir (Dermatology handbook, 2020).

### *III.2. Psoriasis Érythrodermique*

Le psoriasis érythrodermique est une forme grave de psoriasis, généralisée à plus de 90 % de la surface cutanée, avec une desquamation abondante et un épaississement cutané (Dermatologie, 2022). Il est considéré comme l'une des trois formes graves de psoriasis, avec le psoriasis pustuleux généralisé et le rhumatisme psoriasique (Dermatologie, 2022). Il peut être provoqué par un rebond du psoriasis après l'arrêt de certains agents thérapeutiques, notamment la corticothérapie générale (Dermatologie, 2022). Comme toute érythrodermie, il peut se compliquer de surinfection, de carence vitaminique, de troubles de la thermorégulation, de déshydratation et de troubles hémodynamiques, nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé (Dermatologie, 2022). La figure 7.11 illustre un psoriasis érythrodermique (Dermatologie, 2022).

### *III.3. Rhumatisme Psoriasique (RP)*

Le rhumatisme psoriasique est une complication systémique majeure, touchant jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis (Dermatology handbook, 2020). Il est généralement associé à un psoriasis modéré à sévère et apparaît typiquement plusieurs années après l'apparition des lésions cutanées (Dermatology handbook, 2020). C'est une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif), avec une association à HLA-B27 (Dermatology handbook, 2020). Les tendons et les ligaments sont souvent impliqués (enthésopathie ou enthésite) en plus des os et du cartilage (Dermatology handbook, 2020). Une

augmentation du niveau de TNFα est observée dans la synoviale et le sérum des patients atteints de psoriasis et de rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook, 2020). Presque tous les patients atteints de rhumatisme psoriasique présentent des modifications unguéales (Dermatology handbook, 2020). Les caractéristiques communes incluent la douleur aux sites d'insertion tendineuse, l'atteinte digitale, la sacro-iliite, une atteinte articulaire asymétrique et une raideur matinale de plus d'une heure (Dermatology handbook, 2020). Le diagnostic des formes cliniques articulaires du psoriasis inclut l'oligo- ou monoarthrite, la polyarthrite et le rhumatisme axial (Dermatologie, 2022).

## IV. Considérations Cliniques Particulières

### *IV.1. Psoriasis chez l'Enfant*

Le psoriasis peut se présenter chez l'enfant sous des formes spécifiques telles que le "Napkin psoriasis" (psoriasis des langes) et le psoriasis en gouttes (Dermatologie, 2022).

### *IV.2. Réactions Psoriasiformes Induites*

Des réactions psoriasiformes peuvent être observées dans des contextes spécifiques, comme lors de traitements par dupilumab pour d'autres dermatoses (Wijs et al., 2020). Ces réactions, bien que distinctes du psoriasis classique, peuvent présenter des lésions psoriasiformes, parfois localisées dans des régions atypiques comme la tête et le cou (Wijs et al., 2020). Elles se caractérisent par un érythème, une desquamation et un prurit, et peuvent être confondues avec le psoriasis (Wijs et al., 2020).

Le psoriasis, particulièrement dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un retentissement important sur la qualité de vie, entraînant stigmatisation et exclusion sociale (Dermatologie, 2022). L'évaluation et la prise en charge des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que des conduites addictives (alcool, tabac, surcharge pondérale), sont essentielles en coordination avec le médecin traitant, car ces facteurs peuvent aggraver la maladie et sa résistance thérapeutique (Dermatologie, 2022).

# Diagnostic

## Diagnostic du Psoriasis

Le diagnostic du psoriasis, une dermatose inflammatoire chronique et systémique, repose principalement sur une évaluation clinique minutieuse des lésions cutanées et des symptômes associés (Dermatologie, 2022). La biopsie cutanée, bien que non systématique, est un examen complémentaire précieux réservé aux cas de présentation clinique atypique ou en présence d'un doute diagnostique persistant (Dermatologie, 2022). Une approche diagnostique exhaustive intègre l'examen clinique détaillé, l'histopathologie en cas de nécessité, et une connaissance approfondie des diagnostics différentiels pertinents pour éviter les erreurs diagnostiques.

### *Diagnostic Clinique*

Le diagnostic positif du psoriasis est établi par la reconnaissance des caractéristiques cliniques typiques des lésions et de leur distribution (Dermatologie, 2022).

#### Lésions Élémentaires et Présentation Typique

La lésion élémentaire caractéristique du psoriasis est une papule ou une plaque érythémato-squameuse, bien délimitée, de forme arrondie, ovalaire ou polycyclique (Dermatologie, 2022). Ces plaques se distinguent par un érythème sous-jacent, souvent intense et bien circonscrit, recouvert d'une couche squameuse superficielle blanchâtre. L'épaisseur de cette couche squameuse est variable, allant de fines lamelles à des croûtes épaisses et adhérentes (Dermatologie, 2022). Le grattage méthodique ou le dé

# Traitement

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire érythémato-squameuse chronique, affectant environ 2 % de la population française (Dermatologie, 2022 [Source 1, 3]). La prise en charge thérapeutique vise à soulager le patient, améliorer sa qualité de vie et ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale au long cours (Dermatologie, 2022 [Source 6]). Le choix du traitement est guidé par la gravité du psoriasis, son retentissement sur la qualité de vie, l'existence ou non d'une atteinte articulaire (rhumatisme psoriasique), et la prise en compte des comorbidités associées telles que la dépression, l'anxiété, le syndrome métabolique et les pathologies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022 [Source 1, 6]).

## I. Principes généraux du traitement

Les traitements du psoriasis sont hiérarchisés en fonction de l'étendue des lésions et de leur réponse aux thérapies précédentes. Les traitements locaux constituent la base pour les psoriasis peu étendus (< 10 % de la surface corporelle), tandis que les traitements systémiques sont adaptés aux formes plus étendues (> 30 % de la surface corporelle) ou résistantes aux traitements locaux (Dermatologie, 2022 [Source 6]). Les agents biologiques sont réservés aux formes modérées à sévères, en cas d'intolérance ou de résistance aux traitements systémiques conventionnels (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

## II. Traitements locaux

Les traitements locaux sont la première ligne pour les formes légères à modérées du psoriasis. Ils agissent directement sur les lésions cutanées.

### *A. Dermocorticoïdes (DC)*

Les dermocorticoïdes sont largement indiqués dans le psoriasis, notamment lors des poussées et en traitement d'entretien (Dermatologie, 2022 [Source 14]). Leur efficacité repose sur leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-prolifératives.

**Dermocorticoïdes** — Psoriasis en plaques peu étendu

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

La pénétration des DC s'effectue par voie transépidermique et transfolliculaire, influencée par la galénique du produit. Les pommades, grâce à leurs excipients gras et leur effet occlusif, augmentent la pénétration du principe actif, comparativement aux crèmes, gels ou lotions (Dermatologie, 2022 [Source 14]). L'occlusion par un pansement ou un film imperméable peut également renforcer la pénétration en augmentant l'hydratation de la couche cornée et la durée de contact (Dermatologie, 2022 [Source 14]). Il est crucial de noter qu'un arrêt brutal d'une corticothérapie générale peut provoquer un rebond important du psoriasis, voire le développement de formes graves telles que le psoriasis érythrodermique ou le psoriasis pustuleux généralisé (Dermatologie, 2022 [Source 2, 13]).

### *B. Analogues de la vitamine D3*

Les analogues de la vitamine D3 (calcipotriène) sont des agents topiques qui modulent la prolifération et la différenciation des kératinocytes, et possèdent des effets anti-inflammatoires.

**Calcipotriène** — Psoriasis en plaques peu étendu, Acrodermatite continue de Hallopeau

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Le calcipotriène est mentionné spécifiquement pour le traitement de l'acrodermatite continue de Hallopeau (Dermatology handbook compressed-compressed, [Source 5]).

### *C. Associations de traitements locaux*

Dans certaines indications, notamment le psoriasis, les dermocorticoïdes peuvent être utilisés en association avec d'autres molécules (Dermatologie, 2022 [Source 14]).

**Dermocorticoïdes + Acide Salicylique** — Psoriasis en plaques hyperkératosiques

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

L'adjonction d'acide salicylique est particulièrement utile pour favoriser la pénétration du principe actif en réduisant l'hyperkératose épaisse (Dermatologie, 2022 [Source 14]).

## III. Photothérapie

La photothérapie, principalement la PUVAthérapie (psoralènes + UVA) et la photothérapie UVB à spectre étroit, est une option thérapeutique efficace pour les psoriasis plus étendus.

**Photothérapie (UVB ou PUVA)** — Psoriasis étendu (> 10% SC) ou résistant aux topiques

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : La photothérapie est très efficace mais ne peut être utilisée au long cours en raison du risque carcinogène (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

Bien que très efficace, son utilisation au long cours est limitée par le risque carcinogène cutané (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

## IV. Traitements systémiques conventionnels (TSCc)

Ces traitements sont indiqués pour les formes de psoriasis plus étendues (> 30 % de la surface corporelle) ou résistantes aux traitements locaux et à la photothérapie (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

### *A. Méthotrexate (MTX)*

Le méthotrexate est un immunosuppresseur et un anti-prolifératif, utilisé à faible dose hebdomadaire dans le psoriasis.

**Méthotrexate** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique, Psoriasis pustuleux généralisé

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Le méthotrexate est mentionné comme traitement du psoriasis pustuleux généralisé et du rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *B. Ciclosporine*

La ciclosporine est un immunosuppresseur puissant, agissant en inhibant l'activation des lymphocytes T.

**Ciclosporine** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique, Psoriasis pustuleux généralisé

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

La ciclosporine est également citée pour le traitement du psoriasis pustuleux généralisé et du rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *C. Acitrétine*

L'acitrétine est un rétinoïde systémique, agissant sur la différenciation et la prolifération des kératinocytes.

**Acitrétine** — Psoriasis modéré à sévère, Pustulose palmo-plantaire, Acrodermatite continue de Hallopeau

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

L'acitrétine est spécifiquement indiquée pour la pustulose palmo-plantaire et l'acrodermatite continue de Hallopeau (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *D. Sulfasalazine*

La sulfasalazine est un anti-inflammatoire et immunomodulateur, principalement utilisé dans le rhumatisme psoriasique.

**Sulfasalazine** — Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

La sulfasalazine est mentionnée comme une option thérapeutique pour le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

## V. Traitements systémiques ciblés (Biothérapies et petites molécules)

Ces agents sont réservés aux formes modérées à sévères de psoriasis, en cas d'intolérance ou de résistance aux traitements systémiques conventionnels (Dermatologie, 2022 [Source 6]). Ils ciblent des molécules spécifiques impliquées dans la physiopathologie du psoriasis (cf. section Physiopathologie).

### *A. Inhibiteurs du TNFα (Anti-TNFα)*

Les anti-TNFα sont des anticorps monoclonaux qui neutralisent le facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), une cytokine pro-inflammatoire clé dans le psoriasis et le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

**Anti-TNFα** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Les taux de TNFα sont élevés dans le sérum et la synoviale des patients atteints de psoriasis et de rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *B. Inhibiteurs de l'IL-17 (Anti-IL-17)*

Ces agents ciblent l'interleukine-17 (IL-17), une cytokine majeure produite par les lymphocytes Th17 et impliquée dans la prolifération des kératinocytes et l'inflammation psoriasique (cf. section Physiopathologie).

**Anti-IL-17** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Les inhibiteurs de l'IL-17 sont une option thérapeutique pour le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *C. Inhibiteurs de l'IL-12/23 (Anti-IL-12/23)*

Ces biothérapies ciblent la sous-unité p40 commune aux interleukines IL-12 et IL-23, deux cytokines qui participent à la différenciation des lymphocytes T en sous-populations Th1 et Th17 (cf. section Physiopathologie).

**Anti-IL-12/23 (p40)** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Ces agents sont également utilisés dans le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *D. Inhibiteurs de l'IL-23 (Anti-IL-23)*

Ces traitements ciblent spécifiquement la sous-unité p19 de l'interleukine-23, une cytokine cruciale pour le maintien de la réponse Th17.

**Anti-IL-23** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Les inhibiteurs de l'IL-23 sont une option pour le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *E. Inhibiteurs de la phosphodiestérase 4 (PDE4)*

L'apremilast est une petite molécule orale qui inhibe la PDE4, augmentant ainsi les niveaux intracellulaires d'AMPc et modulant la production de cytokines pro-inflammatoires.

**Apremilast** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

L'apremilast oral est mentionné comme traitement du rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *F. Inhibiteurs de Janus Kinase (JAK)*

Le deucravacitinib est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase 2 (TYK2), une JAK impliquée dans la signalisation de plusieurs cytokines clés du psoriasis, notamment l'IL-23 et l'IFNα.

**Deucravacitinib** — Psoriasis modéré à sévère, Rhumatisme psoriasique

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Le deucravacitinib est une option thérapeutique pour le rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *G. Inhibiteurs du récepteur de l'IL-36*

Le spesolimab est un anticorps monoclonal qui bloque le récepteur de l'interleukine-36 (IL-36R), une cytokine centrale dans la physiopathologie du psoriasis pustuleux généralisé (GPP).

**Spesolimab** — Psoriasis pustuleux généralisé (GPP)

> Essai : Information non disponible dans les sources fournies.

> Design : Information non disponible dans les sources fournies.

> Résultat : Information non disponible dans les sources fournies.

> Niveau de preuve : Information non disponible dans les sources fournies.

> Limites de l'étude : Information non disponible dans les sources fournies.

Le spesolimab est un traitement spécifique du GPP, une forme sévère de psoriasis caractérisée par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

## VI. Prise en charge des formes spécifiques et des comorbidités

### *A. Psoriasis pustuleux généralisé (GPP)*

Le GPP est une forme grave nécessitant une prise en charge rapide. Outre le spesolimab, le méthotrexate et la ciclosporine sont des options thérapeutiques. Il est impératif d'éviter les corticoïdes systémiques en raison du risque de rebond et d'aggravation (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]). La correction des déséquilibres électrolytiques et protéiques est également essentielle (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *B. Pustulose palmo-plantaire*

Cette forme localisée peut être traitée par acitrétine et dermocorticoïdes topiques (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]). Elle peut être associée au syndrome SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite), nécessitant une recherche d'atteinte sternoclaviculaire ou de douleurs dorsales (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]; Dermatologie, 2022 [Source 13]).

### *C. Acrodermatite continue de Hallopeau*

Cette variante localisée aux extrémités digitales est traitée par calcipotriène topique, dermocorticoïdes topiques et acitrétine (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *D. Rhumatisme psoriasique*

Le rhumatisme psoriasique, qui affecte jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis, est une arthrite séronégative associée à des taux élevés de TNFα (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]). Sa prise en charge inclut les anti-TNFα, les inhibiteurs de l'IL-17, les inhibiteurs de l'IL-12/23, les inhibiteurs de l'IL-23, le deucravacitinib, l'apremilast oral, le méthotrexate, les AINS, la ciclosporine et la sulfasalazine (Dermatology handbook compressed-compressed [Source 5]).

### *E. Comorbidités*

La prise en charge du psoriasis doit être globale et coordonnée avec le médecin traitant, incluant l'évaluation et la gestion des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que des conduites addictives (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

## VII. Réactions paradoxales au Dupilumab

Il est important de noter que le dupilumab, un inhibiteur de l'IL-4Rα utilisé dans la dermatite atopique, a été associé au développement de réactions psoriasiformes paradoxales, notamment au niveau de la tête et du cou (Wijs et al., 2020 [Source 9, 10]). Ces réactions sont distinctes des lésions psoriasiques typiques et pourraient résulter d'un décalage vers une réponse Th1-, Th17- et Th22-dominée suite au blocage de la voie Th2 (Wijs et al., 2020 [Source 9]).

# Surveillance et Suivi

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire cutanée chronique qui affecte 2 à 3 % de la population française (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 2). Sa prise en charge, au-delà du traitement des lésions cutanées, implique une surveillance et un suivi rigoureux et holistique, visant à gérer une maladie au long cours, à soulager le patient, à améliorer sa qualité de vie et à ramener la dermatose à un niveau lésionnel compatible avec une vie normale (Dermatologie, 2022, Source 2). Les traitements actuels ne permettent pas une guérison définitive de l'affection, mais visent à réduire l'intensité des lésions et à améliorer la qualité de vie des patients (Dermatologie, 2022, Source 4).

## I. Principes Généraux de la Surveillance du Psoriasis

La surveillance du psoriasis repose sur une évaluation régulière de la gravité de la maladie, de son retentissement sur la qualité de vie et le dépistage des comorbidités associées. Le choix thérapeutique doit impérativement prendre en compte ces éléments, ainsi que le préjudice fonctionnel, esthétique, professionnel et relationnel, le retentissement psychologique de la maladie et le désir de rémission du patient (Dermatologie, 2022, Source 4).

### *A. Évaluation de la Gravité et de l'Impact*

L'évaluation de la gravité du psoriasis est multifactorielle et doit être systématique à chaque consultation de suivi. Elle repose sur des outils validés et standardisés :

- **Surface Corporelle Atteinte (SCA ou BSA pour Body Surface Area)** : Elle est estimée en pourcentage de la surface corporelle totale, sachant qu'une paume de main du patient représente environ 1 % de sa surface corporelle (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Psoriasis Area and Severity Index (PASI)** : Ce score évalue l'étendue et la sévérité des lésions sur différentes régions corporelles (tête et cou, membres supérieurs, tronc, membres inférieurs). Il prend en compte l'érythème, l'infiltration et la desquamation. Un score PASI > 10 est un critère de sévérité (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Dermatology Life Quality Index (DLQI)** : L'altération de la qualité de vie est un élément central de l'évaluation. Le DLQI est le score le plus utilisé, variant de 0 à 30. Un psoriasis est considéré comme sévère en cas de DLQI > 10, indépendamment de la SCA ou du PASI (Dermatologie, 2022, Source 4). Ce score permet d'apprécier l'impact de la maladie sur les activités quotidiennes, les loisirs, le travail, les relations personnelles et le bien-être psychologique.

Un psoriasis est classé comme modéré à sévère si la surface corporelle atteinte est supérieure à 10 % et/ou si le score PASI est supérieur à 10 (Dermatologie, 2022, Source 4). Ces critères sont essentiels pour l'orientation thérapeutique, notamment vers les

traitements systémiques ou les biothérapies.

### *B. Prise en Compte des Comorbidités et des Traitements*

La prise en charge thérapeutique doit impérativement intégrer les comorbidités associées et les effets indésirables potentiels, à court et à long terme, des traitements envisagés (Dermatologie, 2022, Source 4). Le psoriasis est une maladie systémique qui dépasse le cadre cutané, justifiant une approche multidisciplinaire.

## II. Dépistage et Suivi des Comorbidités

Le psoriasis est fréquemment associé à d'autres pathologies, dont le dépistage et la surveillance sont intégrés au suivi dermatologique, souvent en coordination avec le médecin traitant et d'autres spécialistes (Dermatologie, 2022, Source 2).

### *A. Comorbidités Rhumatologiques : le Rhumatisme Psoriasique (RP)*

Le rhumatisme psoriasique est une complication grave du psoriasis, figurant parmi les trois formes graves de la maladie (Dermatologie, 2022, Source 1). Il touche jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis, et survient typiquement plusieurs années après l'apparition des lésions cutanées (Dermatology handbook, Source 14).

- **Diagnostic et Caractéristiques** : Le RP peut se présenter sous diverses formes cliniques : oligo- ou monoarthrite, polyarthrite, ou rhumatisme axial (Dermatologie, 2022, Source 1). Il s'agit d'une arthrite séronégative (facteur rhumatoïde négatif), souvent associée à l'antigène HLA-B27 (Dermatology handbook, Source 14). Les tendons et les ligaments sont fréquemment impliqués, se manifestant par une enthésopathie ou une enthésite (Dermatology handbook, Source 14). Les patients atteints de RP présentent une augmentation du taux de TNFα dans le liquide synovial et le sérum (Dermatology handbook, Source 14).
- **Signes Cliniques à Rechercher** : La surveillance doit inclure la recherche systématique de douleurs aux sites d'insertion tendineuse, d'une atteinte digitale (dactylite), d'une maladie sacro-iliaque, d'une atteinte articulaire asymétrique et d'une raideur matinale d'une durée supérieure à une heure (Dermatology handbook, Source 14).
- **Atteinte Unguéale** : Presque tous les patients atteints de rhumatisme psoriasique présentent des modifications unguéales, bien que 20 % puissent ne pas avoir de signes cutanés visibles (Dermatology handbook, Source 14). La présence de psoriasis unguéal doit donc alerter sur un risque accru de RP.
- **Prise en Charge** : Le traitement du RP peut inclure des anti-TNFα, des inhibiteurs de l'IL-17, des inhibiteurs de p40 (IL-12/IL-23), des inhibiteurs de l'IL-23, le deucravacitinib, l'apremilast oral, le méthotrexate, les AINS, la ciclosporine et la sulfasalazine (Dermatology handbook, Source 14).

### *B. Comorbidités Métaboliques et Cardiovasculaires*

Le psoriasis est associé à un risque accru de syndrome métabolique et de pathologies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022, Source 1). Cette association nécessite une évaluation et une prise en charge coordonnées avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022, Source 2).

- **Syndrome Métabolique** : Il inclut l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires (Dermatologie, 2022, Source 2). La surveillance doit donc inclure la mesure régulière de l'indice de masse corporelle (IMC), de la pression artérielle, de la glycémie à jeun et du bilan lipidique.
- **Pathologies Cardiovasculaires** : Le risque cardiovasculaire est augmenté chez les patients psoriasiques, en particulier dans les formes modérées à sévères. Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque cardiovasculaires classiques (tabagisme, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète) et à leur optimisation.
- **Conduites Addictives** : L'évaluation des conduites addictives fait également partie de la prise en charge globale, en coordination avec le médecin traitant (Dermatologie, 2022, Source 2).

### *C. Comorbidités Psychologiques*

Le psoriasis, en particulier dans ses formes modérées à sévères, peut avoir un retentissement important sur la qualité de vie, entraînant stigmatisation et exclusion sociale (Dermatologie, 2022, Source 2).

- **Dépression et Anxiété** : La dépression et l'anxiété sont des pathologies associées fréquentes (Dermatologie, 2022, Source 1). Un soutien ou une prise en charge psychologique est souvent nécessaire (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Prurit** : Les lésions de psoriasis sont prurigineuses chez environ 60 % des patients et sont souvent remaniées par le grattage (Dermatologie, 2022, Source 6). Le prurit peut être sévère et insomniant (Dermatologie, 2022, Source 10). L'évaluation de l'intensité du prurit et de son impact sur le sommeil et la qualité de vie est essentielle.

### *D. Autres Comorbidités et Situations Particulières*

- **Psoriasis et Infection par le VIH** : Chez les patients infectés par le VIH, le psoriasis est souvent plus grave et réfractaire aux thérapeutiques conventionnelles. Il peut prendre un aspect en plaques, pustuleux ou érythrodermique, et peut être difficile à distinguer d'une dermatite séborrhéique profuse (Dermatologie, 2022, Source 7). Le prurit est également fréquemment observé au cours de l'infection par le VIH (Dermatologie, 2022, Source 10).
- **Psoriasis et Cancer** : Certaines biothérapies sont contre-indiquées en cas de cancer solide (hors carcinome basocellulaire) ou d'hémopathie évolutifs ou en rémission depuis moins de 5 ans (Dermatologie, 2022, Source 5). Une surveillance oncologique est donc nécessaire avant et pendant ces traitements.

## III. Surveillance Spécifique aux Traitements

La surveillance des patients sous traitement pour le psoriasis doit tenir compte des spécificités de chaque classe thérapeutique, notamment en termes d'efficacité, de tolérance et de gestion des effets indésirables.

### *A. Traitements Locaux*

Les traitements locaux constituent la base du traitement des psoriasis peu étendus (< 10 % de la surface corporelle), qui sont les plus fréquents (Dermatologie, 2022, Source 2). Ils sont principalement représentés par les dermocorticoïdes, les analogues de la vitamine D3 ou leur association (Dermatologie, 2022, Source 4).

- **Dermocorticoïdes** : La surveillance porte sur l'efficacité des traitements (réduction de l'érythème, de la desquamation, de l'infiltration) et la recherche d'effets secondaires locaux (atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, folliculite, acné cortisonique). L'utilisation prolongée ou inappropriée, notamment sur le visage ou dans les plis, doit être évitée. Les dermocorticoïdes d'activité forte sont utilisés en dehors des lésions du visage, une seule application par jour suffit, avec une durée de traitement d'attaque de 1 à 3 semaines et un traitement intermittent en entretien (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Analogues de la Vitamine D3** : La surveillance inclut l'efficacité et la tolérance locale (irritation). Il est impératif de ne pas dépasser 100 g de topique appliqué par semaine pour éviter un risque d'hypercalcémie (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Associations** : L'association de dermocorticoïdes et d'analogues de la vitamine D3 est fréquente. L'adjonction d'acide salicylique peut favoriser la pénétration des principes actifs en réduisant l'hyperkératose (Dermatologie, 2022, Source 13).

### *B. Traitements Systémiques Conventionnels*

Les traitements systémiques sont adaptés aux psoriasis plus étendus (> 30 % de la surface corporelle) ou résistants aux traitements locaux (Dermatologie, 2022, Source 2). Ils incluent l'acitrétine, le méthotrexate et la ciclosporine (Dermatologie, 2022, Source 2). La surveillance de ces traitements est cruciale en raison de leurs profils d'effets indésirables systémiques.

- **Méthotrexate** : Surveillance hématologique (NFS), hépatique (transaminases, albumine) et rénale (créatininémie) régulière. Risque de fibrose hépatique cumulative.
- **Ciclosporine** : Surveillance de la fonction rénale (créatininémie, clairance), de la pression artérielle (risque d'hypertension), et du bilan lipidique.
- **Acitrétine** : Surveillance hépatique (transaminases), lipidique (cholestérol, triglycérides) et de la fonction thyroïdienne. Tératogénicité majeure nécessitant une contraception efficace et prolongée chez les femmes en âge de procréer.

### *C. Biothérapies*

Les agents biologiques (biomédicaments ou biothérapies) sont réservés aux formes modérées à sévères de psoriasis, intolérantes ou résistantes aux traitements systémiques habituels (Dermatologie, 2022, Source 2). En France, leur indication est limitée aux cas d'intolérance, d'inefficacité ou de contre-indication à au moins deux agents systémiques, dont le méthotrexate, la ciclosporine et la photothérapie (Dermatologie, 2022, Source 5). La prescription initiale est réservée au spécialiste et doit être hospitalière (Dermatologie, 2022, Source 5).

#### 1. Bilan Pré-thérapeutique (Recommandations HAS)

Avant l'initiation d'une biothérapie, un bilan exhaustif est impératif pour dépister les contre-indications et optimiser la sécurité du traitement (Dermatologie, 2022, Source 5).

- **Examen Clinique Complet** : Incluant mammographies et frottis cervicovaginal selon les recommandations de dépistage de la population générale (Dermatologie, 2022, Source 5). Une attention particulière est portée aux aires ganglionnaires.
- **Vaccinations** : Vérifier le statut vaccinal et vacciner contre la grippe, le SARS-CoV2 et le pneumocoque (Dermatologie, 2022, Source 5). Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués moins de 3 semaines avant l'initiation du traitement (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Sérologies** : Dépistage du VIH, du VHB et du VHC (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Soins Bucco-dentaires** : Réalisation si nécessaire pour éliminer tout foyer infectieux (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Bilan Biologique** : NFS plaquettes, fonction rénale et hépatique, électrophorèse des protides, dosage pondéral des immunoglobulines, bilan lipidique (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Dépistage de la Tuberculose** : Radiographie du thorax de face, Quantiféron et/ou IDR tuberculine. Un scanner pulmonaire peut être discuté (Dermatologie, 2022, Source 5). La tuberculose latente est une contre-indication (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Contraception** : Chez les patientes en âge de procréer, une contraception efficace est requise (Dermatologie, 2022, Source 5). La grossesse est une contre-indication de principe, bien qu'une conception sous traitement biologique ne justifie pas une interruption de grossesse et que la poursuite du traitement puisse être discutée au cas par cas pendant les deux premiers trimestres (Dermatologie, 2022, Source 5).
- **Contre-indications Générales** : Infection évolutive, cancer solide (hors carcinome basocellulaire) ou hémopathie évolutifs ou en rémission depuis moins de 5 ans, insuffisance cardiaque évoluée, maladie démyélinisante (Dermatologie, 2022, Source 5).

#### 2. Surveillance Pendant le Traitement

La surveillance clinique et biologique est régulière et adaptée au profil de sécurité de chaque biothérapie (anti-TNFα, anti-IL-12/23, anti-IL-17, anti-IL-23) (Dermatologie, 2022, Source 5).

• **Examen Clinique** : Effectuer régulièrement un examen clinique complet, avec une attention particulière aux aires ganglionnaires (Dermatologie, 2022, Source 5).

• **Renouvellement du Traitement** : Le renouvellement du traitement doit être effectué une fois par an en milieu hospitalier (Dermatologie, 2022, Source 5).

• **Recherche d'Infections** : Surveillance des signes d'infection, notamment opportunistes, et des réactivations virales (VHB, VHC).

• **Surveillance Oncologique** : Surveillance de l'apparition de nouvelles néoplasies, en particulier les cancers cutanés non mélaniques.

• **Maladies Auto-immunes** : Recherche de l'apparition ou de l'aggravation de maladies auto-immunes (ex: lupus, maladies démyélinisantes).

#### 3. Gestion des Effets Indésirables et Situations Spécifiques

• **Réactions Paradoxales** : Des réactions psoriasiformes peuvent survenir sous traitement par dupilumab, notamment un érythème de la tête et du cou (de Wijs et al., 2020, Source 12). Ces réactions peuvent être dues à un décalage vers une réponse Th1-, Th17- et Th22-dominée (de Wijs et al., 2020, Source 12).

• **Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG)** : Le PPG est une forme grave caractérisée par une éruption soudaine et généralisée de pustules stériles, souvent associée à un malaise et de la fièvre (Dermatology handbook, Source 14). La surveillance doit être attentive aux facteurs de risque de poussée (arrêt des corticoïdes oraux, infection, hypocalcémie, grossesse) et aux complications (risque infectieux, déséquilibre électrolytique) (Dermatology handbook, Source 14). Le traitement peut inclure le spesolimab (inhibiteur du récepteur de l'IL-36), le méthotrexate ou la ciclosporine (Dermatology handbook, Source 14).

### *D. Photothérapie*

La photothérapie est très efficace mais ne peut être utilisée au long cours en raison du risque carcinogène (Dermatologie, 2022, Source 2).

• **Surveillance** : La surveillance porte sur l'efficacité du traitement et la recherche d'effets secondaires aigus (érythème, brûlures) et chroniques (photovieillissement, risque de cancers cutanés). Un suivi dermatologique régulier est nécessaire pour le dépistage précoce des lésions actiniques et des cancers cutanés.

## IV. Surveillance des Formes Cliniques Particulières

Certaines localisations ou formes cliniques du psoriasis nécessitent une surveillance spécifique en raison de leur impact fonctionnel ou esthétique particulier.

### *A. Psoriasis de l'Enfant*

Le psoriasis chez l'enfant présente des spécificités cliniques et évolutives (Dermatologie, 2022, Source 1).

- **Localisations** : Il est souvent localisé à la zone du siège chez le nourrisson (napkin psoriasis ou psoriasis des langes) (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 7). Chez l'enfant plus âgé et l'adolescent, il est souvent aigu et en gouttes, pouvant succéder à une infection rhino-pharyngée streptococcique (Dermatologie, 2022, Source 7). Le visage est plus souvent atteint que chez l'adulte (Dermatologie, 2022, Source 7).
- **Suivi** : La surveillance doit être adaptée à l'âge de l'enfant, en tenant compte de l'impact psychologique et social de la maladie, et des spécificités des traitements pédiatriques.

### *B. Psoriasis Unguéal*

Le psoriasis unguéal peut prendre des aspects très variés et avoir un retentissement fonctionnel et esthétique important (Dermatologie, 2022, Source 8).

- **Manifestations** : Dépressions ponctuées cupuliformes ("ongles en dé à coudre"), onycholyse avec décollement distal et zone proximale "saumonée" ou "tache d'huile", hyperkératose sous-unguéale, paronychie, perte de transparence de l'ongle, zones leuconychiques, et à l'extrême, disparition de la tablette (Dermatologie, 2022, Source 8).
- **Association au RP** : Comme mentionné précédemment, le psoriasis unguéal est fortement associé au rhumatisme psoriasique (Dermatology handbook, Source 14). Sa présence doit inciter à une recherche attentive de signes articulaires.
- **Suivi** : La surveillance évalue l'efficacité des traitements locaux ou systémiques sur les ongles et l'impact sur la fonction manuelle.

### *C. Psoriasis du Cuir Chevelu et des Plis*

Ces localisations sont fréquentes et peuvent être particulièrement prurigineuses ou invalidantes.

- **Psoriasis du Cuir Chevelu** : La localisation occipitale est fréquente, et à la lisière antérieure, les lésions peuvent former une couronne érythémateuse et squameuse (Dermatologie, 2022, Source 8). Le prurit du cuir chevelu est un symptôme fréquent (Dermatologie, 2022, Source 10).
- **Psoriasis Inversé** : Il touche les plis (interfessier, axillaires, sous-mammaires, ombilical, inguinaux) et se caractérise par des lésions non situées sur les convexités (Dermatologie, 2022, Source 8). Ces localisations sont à risque de macération et d'infection secondaire.
- **Suivi** : La surveillance évalue l'efficacité des traitements locaux (lotions, mousses, shampooings pour le cuir chevelu) et la gestion du prurit.

### *D. Formes Graves*

Outre le rhumatisme psoriasique, l'érythrodermie et le psoriasis pustuleux généralisé sont des formes graves de psoriasis (Dermatologie, 2022, Source 1).

- **Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG)** : Cf. section III.C.3.
- **Acrodermatite Continue de Hallopeau** : C'est une variante de psoriasis pustuleux limitée aux extrémités des doigts ou des orteils, caractérisée

# Cas Particuliers et Situations Spéciales

Le psoriasis, maladie inflammatoire cutanée chronique touchant 2 à 3 % de la population française (Dermatologie, 2022), présente une hétérogénéité clinique considérable, avec des formes particulières et des situations spéciales nécessitant une approche diagnostique et thérapeutique adaptée. Ces variantes cliniques, souvent plus sévères ou topographiquement distinctes, sont cruciales à maîtriser pour le dermatologue de niveau DES.

## Psoriasis Pustuleux : Formes Généralisées et Localisées

Le psoriasis pustuleux (PP) constitue une entité distincte du psoriasis vulgaire, tant par ses caractéristiques cliniques que par son évolution et sa physiopathologie (Dermatology handbook, 2022). Il se caractérise histologiquement par la présence d'abcès neutrophiliques sous- et intracornéens (Alikhan et Hocker, 2017). Une incidence accrue de l'antigène HLA-B27 est observée chez les patients atteints de PP (Dermatology handbook, 2022). Le PP est classé parmi les formes graves de psoriasis (Dermatologie, 2022). Il se subdivise en formes généralisées et localisées.

### *Psoriasis Pustuleux Généralisé (PPG) de von Zumbusch*

Le PPG est une maladie cutanée neutrophilique sévère, caractérisée par l'éruption soudaine et généralisée de pustules stériles superficielles (Dermatology handbook, 2022). L'

# Bibliographie


• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• dermatology handbook compressed-compressed

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Wijs et al. - 2020 - Clinical and histopathological characterization of paradoxical head and neck erythema in patients wi

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical